Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90 - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51)3098-5599 - Email: frviamao2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5020484-37.2021.8.21.0039/RS

AUTOR: KARLA SIMONE DE OLIVEIRA FEIJO
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE VIAMÃO / RS

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

KARLA SIMONE DE OLIVEIRA FEIJO patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ingressou contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e o **MUNICÍPIO DE VIAMÃO,** todos qualificados nos autos, com uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, referindo ter 50 anos de idade, e, segundo laudo médico, sofre de "Retinopatia Diabética – CID 10 H36.0", necessitando de forma urgente do medicamento Aflibercepte 40mg/ml, a ser aplicado em injeções intravítreas, com intervalo mensal, em ambos os olhos (mínimo cinco aplicações em cada olho), sendo que após esse período (dose de carga) as aplicações poderão ser bimestrais, a depender da evolução clínica. O atraso no acesso ao tratamento específico pode acarretar "cegueira irreversível". Sustentou não ter condições financeiras de arcar com os custos de tal medicação, a qual fica em torno de R$ 4.800,00 o frasco, totalizando o valor mensal de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) - (2 frascos – 1 aplicação mensal em cada olho), consoante o menor orçamento em anexo, da Farmácia São João. Assim, o valor anual resulta em R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais). Aduzindo que o direito à saúde é dever do Estado, nos termos dos arts 6º e 196 da CF/88 e 241 da CE, postulou fossem os réus compelidos, inclusive em antecipação de tutela, a disponibilizar o medicamento. Com pedido de assistência judiciária gratuita. Deu à causa o valor de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais).

O juízo deferiu o pedido liminar em razão de seu alto custo (evento 3, DESPADEC1).

Citados ambos os réus, que contestaram, sendo que o MUNICÍPIO DE VIAMÃO arguiu a incompetência do juízo e a ilegitimidade passiva, diante da partilha das responsabilidades entre os entes públicos gestores do SUS, e a violação do princípio constitucional da isonomia, referindo que o fármaco tem alto custo, que não tem previsão orçamentária pelo Município, postulando a acolhida das preliminares e a improcedência da ação (evento 19, CONT1).

Por sua vez, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, alegou que o fornecimento da medicação AFLIBERCEPTE incumbe à União, vez que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde. Destacou o princípio da reserva do possível. Pugnou pela improcedência do pedido e que, em caso de condenação, a prescrição do medicamento seja balizada pela denominação comum brasileira, nos termos do art. 3º da Lei 9787/99. Disse ser descabida a condenação do Estado no ônus sucumbencial, quanto aos honorários pela confusão entre credor e devedor, patrocinada a ação pela Defensoria Pública do Estado, e quanto às custas processuais, pela isenção legal prevista no art. 11 da Lei Estadual 8.121/85, com a redação da Lei Estadual 13.471/10 (evento 22, CONT1).

A parte autora replicou (evento 25, RÉPLICA1).

O Ministério Público lançou parecer (evento 34, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

O juízo julgou procedente o pedido (evento 83, SENT1).

O corréu ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou recurso de apelação no evento 88, APELAÇÃO1, e o autor contrarrazões no evento 93, CONTRAZ1.

Conhecido e provido recurso de apelação pelo Relator Desembargador Eduardo Uhlein, 4ª Câmara Cível do TJRS, com a desconstituição da sentença, a fim de determinar a inclusão da União na relação processual e, por consequência, declinar da competência para a Justiça Federal (evento 16, RELVOTO1).

Os autos retornaram ao juízo comum, diante da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda (evento 140, DESPADEC1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

II - RELATÓRIO

PRELIMINARES. TEMA 793.

É de ser afastada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Viamão para processar e julgar esta causa, cujo valor foi fixado em R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), acima dos 60 (sessenta) salários-mínimos estabelecidos no art. 2º da Lei 12.153/09, confirmando-se a competência do juízo.

Não é caso de remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a responsabilidade dos entes públicos é solidária, conforme arts. 6º, 23, II, e 30, VII, da CF/88 e art. 241 da Constituição Estadual, cabendo somente o repasse posterior de verba compensatória pela União relativamente ao tratamento.

Sucede que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema repetitivo n.º 793 (RE n.º 855178 RG), 16.03.2015[1], ao contrário do que alega a parte contestante, **não criou a obrigação de chamamento da União à lide, tendo reafirmado tão só a responsabilidade solidária dos entes públicos, na fixação da tese de que a responsabilidade em demandas que envolvem o direito à saúde é solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.**

Na sequência, em sede de complementação, em embargos de declaração, julgado em 23.05.2019, com a publicação do acórdão em 16.04.2020, restou sedimentado:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ED no RE 855.178 se, Relator(a): Min. Luiz FUX, julgado em 23.05.2019, public 16.04.2020) (grifei)*

Logo, não há falar em afastamento da solidariedade dos entes públicos, tendo a Corte Suprema apenas reafirmado a tese anteriormente defendida de que:

> *"eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles".*

No sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO Nº 793 DO STF. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. MIELOMA MÚLTIPLO (CID N18). BORTEZOMIBE 3,5MG. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELO ENCAMINHAMENTO DA AUTORA AO CACON/UNACON OU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POSTULADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Para a devida aplicação do referido precedente deve ser analisada a matéria ali em discussão, ou seja, se a União era legítima ou não para figurar no polo passivo. Desta forma, a Suprema Corte, ao julgar o Tema repetitivo nº 793, apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 2. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico. 3. A ausência de inclusão dos medicamentos em listas prévias, quer referente a remédios considerados excepcionais, quer relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados. Da mesma maneira, a forma de organização do SUS não pode obstaculizar o fornecimento de medicamentos. 4. Comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever dos entes públicos encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá aos réus custearem o tratamento da parte autora. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083790402, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020)*

O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O processo, cujo mérito envolve questões fáticas e jurídicas, contendo documentos suficientes à solução da lide, impõe ser julgado antecipadamente, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Cumpre ser observado que o réu não impugnou na respectiva peça de contestação a hipótese diagnóstica da autora, acometida pela patologia classificada como "Retinopatia Diabética – CID 10 H36.0".

Logo, é totalmente despicienda, no caso concreto, a realização da prova pericial, sobretudo porque não há litígio entre as partes relativamente ao diagnóstico e à eficácia da medicação requestada, **fatos estes tidos como incontroversos**.

MÉRITO

A PATOLOGIA. O FÁRMACO.

O medicamento postulado na petição inicial, Aflibercepte**,** tem indicação aprovada para o tratamento de "Retinopatia Diabética – CID 10 H36.0".

O próprio laudo encartado pelo Estado do Rio Grande do Sul dá enfase à incidência do fármaco na seguinte hipótese (evento 22, LAUDO2):

> *"Se comprovada a ocorrência de edema macular diabético em tomografia de coerência ótica que não foi fornecida com a ação, há indicação de um antiangiogênico (anti-VEGF). Mas nesse caso as evidências são favoráveis a qualquer dos antiangiogênicos comercializados para uso intraocular, como o Ranibizumabe (Lucentis®) ou o Aflibercepte (Eylia®), ambos incorporados ao SUS para o tratamento dessa doença.."*

TEMA 106.

Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, há necessidade de atendimento ao Tema 106 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

> *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Pelo laudo juntado, atendendo ao Enunciado 12 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ, expressa-se a inefetividade dos medicamentos disponibilizados pelo sistema SUS, inexistindo outro fármaco que lhe possa substituir.

Confira-se:

> *A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico, que indique e descreva as normas éticas, sanitárias e farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base na medicina de evidências (STJ, Recurso Especial nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção Cível – julgamento repetitivo dia 25.04.2018 – Tema 106), (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).*

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária finalizada no dia 19 de abril de 2023, referendou, por unanimidade, decisão liminar do Ministro Gilmar Mendes, que estabeleceu os parâmetros da atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234:

> *"(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)."*

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 12 de abril de 2023 (acórdão publicado em 18 de abril de 2023), ao julgar o Incidente de Assunção de Competência nº 14, pacificou o entendimento de que

> *"(...) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080 /1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal."*

Ademais, a documentação juntada demonstra a ausência de condições financeiras da parte autora.

Como se depreende do acórdão, cuja ementa abaixo se transcreve, o medicamento aflibercepte tem sido utilizado com eficácia para o tratamento da Retinopatia Diabética – CID 10 H36.0".

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.SAÚDE - RETINOPATIA DIABÉTICA (CID 10 H36.0). MEDICAMENTO - AFLIBERCEPTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO EVIDENCIADO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL - RE Nº 1.366.243 – TEMA 1234. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS. I - Cabe ressaltar a posição do e. STF em sede cautelar, no sentido da distinção jurídico-processual, conforme a padronização do medicamento ou tratamento; bem como do momento da decisão para o cumprimento da obrigação constitucional de prestação do serviço de saúde, com a observância dos parâmetros fixados nos pontos 5.1; 5.2 e 5.3 do Tema 1234 do e. STF - RE nº 1.366.243 -, com vistas a evitar cenário de insegurança jurídica, ao menos até o julgamento definitivo no pretório excelso. II - Portanto, ao menos por ora, evidenciada a competência desta justiça estadual para o julgamento da presente demanda, haja vista o momento processual - sede de recurso de apelação -, consoante o item 5.3. III - De outra parte, a previsão do ressarcimento financeiro do ente público cumpridor do dever, através da compensação, na disciplina dos arts. 19-Q e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. Precedentes deste TJRS. RECURSO DE APELAÇÃO DO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50043032420228210039, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-10-2023)*

De conseguinte, se afigura inadmissível que os réus se recusem a fornecer o tratamento, sob o argumento da ausência de protocolo ou do alto custo medicação, havendo recomendação para a patologia neoplásica cuidada nos autos através de laudo médico fundamento.

A prescrição do medicamento constitui ato médico que, em razão dessa assertiva, não pode sofrer direcionamento ou restrição, seja de natureza legal ou administrativa.

O alto custo do medicamento ou a circunstância de não constar das listas, ou protocolos administrativos de dispensação pelo SUS não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. - ***O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.*** *- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de saúde por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) – grifei.*

No caso concreto, o medicamento Aflibercepte está incorporado ao Sistema Único de Saúde no grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), como parte dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas das seguintes enfermidades: Edema Macular Diabético. Vejamos:

aflibercepte	40 mg/mL	solução injetável	1A	Edema Macular Diabético[2]

Salienta-se que a ação foi ajuizada anteriormente ao TEMA 1234 do STF e que à data do ajuizamento da presente demanda, a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 106 do STJ, amparava o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando evidenciada a necessidade do tratamento e a ineficácia de alternativas oferecidas pelo sistema público.

NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL DOS LAUDOS COM PROVA DE VIDA.

Como se trata de medicamento de alto custo em patologia de alta complexidade, deve a parte autora, **na falta comprovada da medicação em estoque**, apresentar atestados médicos atualizados que comprovem a necessidade e a eficácia do fármaco, conforme a fase da doença, no tratamento em progressão, presumindo-se a desistência no cumprimento em caso de não atendimento.

No sentido, o Enunciado n.º 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde de 18.03.2019.

ENUNCIADO n.º 02

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Desta forma, tendo em vista a necessidade e urgência na realização do tratamento médico pela parte autora, que corre risco de morte pela gravidade da doença, o fornecimento do medicamento solicitado pelos réus é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO:

(i) JULGO PROCEDENTE a ação para condenar os réus na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Aflibercepte 40mg/ml, a ser aplicado em injeções intravítreas, com intervalo mensal, em ambos os olhos (mínimo cinco aplicações em cada olho), sendo que após esse período (dose de carga) as aplicações poderão ser bimestrais, pelo princípio ativo, de acordo com a denominação comum brasileira, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.787/99, no prazo de quinze dias, pena de bloqueio de verba compatível.

(ii) DECLARO, ainda, para nova solicitação de bloqueio, na falta comprovada da medicação em estoque, deverá a parte autora a apresentar relatório médico circunstanciado, com validade para seis meses, nos termos do Enunciado 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, acerca da necessidade de manutenção do tratamento, com prova de vida.

Sucumbentes, os entes públicos réus são isentos do pagamento da taxa única, mas arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), usando-se por analogia o art. 85, §8º, do CPC, já que muito alto o valor da ação, quantia que deverá ser dividida pela metade para cada réu. Suspensa a exigibilidade forte no artigo 98, § 3º, do CPC.

É caso de remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, e da Súmula 490 do STJ, já que a condenação é superior a 100 (cem) salários-mínimos.

Registros e intimações eletrônicas agendadas.

Com o trânsito em julgado, efetue-se a baixa definitiva.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO EDEL LIGORIO FAGUNDES, Juiz de Direito**, em 23/01/2025, às 15:21:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10075432117v5** e o código CRC **137ae273**.

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) ↩